



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : حكمت سعد بولس سمعان
المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : المطرية
رقم البطاقة : 26112280101941 رقم التليفون : 01274550627
العنوان : 00
العمر (تاريخ الميلاد) : 28-12-1961 المهنة : حاصل علي دبلوم
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حكمت سعد بولس سمعان National ID: 26112280101941	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



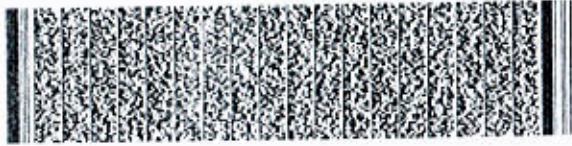


٢٠٢٢/١١ ٢٦١١٢٢٨٠١٠١٩٤١
حاصلته على دبلوم تجارة



أنشى مسيحية متروجة
عاطف عبده حنا بشاره
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/١١/٢٨

١





Patient Name: Hekmat Saad Bolis Samaan	Date : 07/10/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 62 Year(s)
Medical ID: 3592/2019	Pat. ID: 18983

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Left BCS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO views DBT (Digital Breast Tomosynthesis).
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B).

Left breast:

- No sizable operative bed recurrent lesions.
- Complementary ultrasound showed no solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LNs.

Right breast

- No suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Complementary ultrasound showed no solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LNs.

Opinion:

- Status post left BCS showing no sizable operative bed recurrent lesions (BIRADS 2)
- Normal right breast study (BIRADS 1)

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



إدارة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
إدارة المعامل
قسم الباثولوجي

Pathology Report

Name: حكمت سعد بولس

Age: 38 years.



Clinical data: Left breast cancer.

Specimen type: Left wide local excision.

Date: 7/10/2019

Lab. Number: 933

Hospital Number: 3592/2019

Gross Description:

A sector of mammary tissue 10x6.5x5 cm, with partial skin covering 8x3.5 cm. with attached axilla 10x8cm, received enblock. Serial cuts revealed an ill defined firm gritty gray white mass 2.8x2.5cm, located 2cm deep to skin and located (3.5, 3.6, 2, 2 and 1.6 cm) from (lateral, medial, superior, inferior and deep) margins respectively. Axillary dissection revealed 20 nodules up to 2.5cm in diameter.

Microscopic Examination:

Histopathological examination of sections prepared from the tumour mass reveals an infiltrating malignant epithelial growth made up of groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. No intraduct component, could be detected. No lymphovascular emboli or perineural invasion. All of the 20 lymph nodes detected show only reactive hyperplasia 0/20. Skin and surgical margins are free.

Diagnosis:

Left breast mass, wide local excision with axillary clearance,

- Invasive duct carcinoma GII
- No DCIS. No lymphovascular emboli or perineural invasion.
- Free skin.
- Free surgical margins.
- Lymph nodes 0/20.
- Tumor stage pT2 pN0.

Dr. Ehab Omar
Dr. Hana Nessim

Prof. Dr. Ehab Omar